

Skills locomoteurs B3.8

Support d'apprentissage – Coude

Contenu : Dr. Patrick Goetti, Réalisation graphique : Danielyan Vagan (Travail de Master dirigé par Dr. Wehrli)

Nom du test ou de la manœuvre	Description	Photos ou illustration
a. Présentations cliniques fréquentes indiquant la réalisation du test b. Définition de la positivité c. Implications cliniques	a. Position et action du patient b. Action de l'examineur c. Pièges techniques et astuces	
	Par souci de simplicité « patient et examineur » sont écrits au masculin et peuvent aussi être lu comme « patiente et examinatrice ».	

Goniométrie coude (amplitudes articulaires) a. douleurs traumatiques et hématome de la face antérieure du coude après avoir tenté de retenir un objet lourd. b. Impossibilité de pouvoir crocher le tendon du biceps distal c. Une imagerie de confirmation (ultrasonographie ou IRM) doit être demandée rapidement, la <u>prise en charge chirurgicale</u> (réinsertion du tendon sur la tubérosité radiale) doit être rapide (< 2 semaines) pour éviter que le tendon ne se rétracte et complique le geste de réinsertion.	a. Le patient est assis b. L'examineur se place face au patient. La position de départ est la position physiologique (extension complète mais sans hyper-extension). On débute par la mesure de la flexion maximale. Puis de l'extension complète y compris l'hyper-extension. Pour la mesure la pronation et de la supination, on débute par la position physiologique, puis en demande de fléchir le coude de 90°. La pronation (paume de la main vers le bas), puis la supination (paume de la main vers le haut). c. il est important de mesurer les amplitudes articulaires à partir du zéro (position physiologique). Si le patient n'arrive pas à étendre le coude complètement (limité à 30°) cette limite sera noté au milieu : 145-30-0 pour la flexion-position la plus proche du zéro physiologique-extension possible depuis cette position.		
---	--	---	---



Goniométrie :



Hook test (Rupture du biceps distal)

a. douleurs traumatiques et hématome de la face antérieure du coude après avoir tenté de retenir un objet lourd.

b. Impossibilité de pouvoir crocher le tendon du biceps distal

c. Une imagerie de confirmation (ultrasonographie ou IRM) doit être demandée rapidement, la prise en charge chirurgicale (réinsertion du tendon sur la tubérosité radiale) doit être rapide (< 2 semaines) pour éviter que le tendon ne se rétracte et complique le geste de réinsertion

a. Le patient est debout ou assis.

Il est demandé au patient de fléchir le bras en avant coude fléchi, et d'orienter la paume de la main de façon à ce qu'il pourrait lire une annotation inscrite sur la paume de la main.

b. L'examineur se met en face du patient. Avec son index, il va se crocher sur le tendon du biceps distal.

c. Il est important de venir se crocher de supérieur vers inférieur et non l'inverse sinon on risque de confondre le lacertus fibrosus avec le tendon du biceps distal. La palpation est normalement indolore, en cas de douleur on doit suspecter une lésion partielle du tendon et compléter le bilan par une IRM.



Testing en valgus (lésion du ligament collatéral ulnaire)

a. chute sur l'avant-bras en extension. Douleur et hématome sur le versant médial de coude.

b. laxité en valgus asymétrique

c. Il est important d'exclure une fracture associée (tête radiale, processus coronoïde). Une imagerie de confirmation (IRM) doit être demandée, une lésion isolée étant rare.

Référence : Morrey BF et al., Morrey's The Elbow and Its Disorders 5th Edition, Elsevier; 5th edition (July 14, 2017)

b. l'examineur stabilise fermement le bras du patient d'une main. De l'autre main il stabilise l'avant-bras., l'examineur applique une force en valgus avec l'avant-bras en supination (stabilité partielle de tête radiale) puis en pronation (sans stabilité de la tête radiale).

c. il est important de mettre 20-30° de flexion du coude, pour éviter que le processus olécranien ne s'engage dans la fossette olécraniennne et stabilise le coude du point de vue osseux.



Légende :
flèche rouge : mouvement de l'examineur

Testing en varus (lésion du complexe ligamentaire latéral) a. chute sur l'avant-bras en extension. Douleur et hématome sur le versant latéral de coude. b. laxité en varus asymétrique c. Il est important d'exclure une fracture associée (tête radiale, processus coronoïde), cette lésion étant fréquemment retrouvé dans le contexte de luxation du coude. Référence : Morrey BF et al., Morrey's The Elbow and Its Disorders 5th Edition, Elsevier; 5th edition (July 14, 2017)	a. le patient est assis avec le coude en flexion de 20-30° et bras en rotation interne b. l'examineur stabilise fermement le bras du patient d'une main. De l'autre main il stabilise l'avant-bras., l'examineur applique une force en varus avec l'avant-bras. c. il est important de mettre 20° de flexion du coude, pour éviter que le processus olécranien ne s'engage dans la fossette olécraniennne et stabilise le coude du point de vue osseux.	<i>Bientôt disponible</i>	<i>Bientôt disponible</i>
---	---	----------------------------------	----------------------------------

Chair pick-up test ou Lap-top test (épicondylite latérale) a. douleur d'apparition progressive sur le versant latéral du coude. Typiquement retrouvée chez les travailleurs manuel et activités répétitive de dactylographie. b. douleur à l'épicondyle latéral déclenché par le test c. mise en place de physiothérapie, repos, antalgie et éventuellement immobilisation par une attelle. Référence : Orthopaedic Research Institute-Tennis Elbow Testing System: A modified chair pick-up test-interrater and intrarater reliability testing and validity for monitoring lateral epicondylosis. J Shoulder Elbow Surg. 2004 Jan-Feb;13(1):72-7.	a. le patient est debout, coude doit être en extension et l'avant-bras en pronation. b. l'examineur demande au patient de soulever (déplacer) une chaise en la prenant par le dossier. Si le patient rapport une douleur en regard du de l'épicondyle latéral lorsqu'il soulève la chaise, le test est considéré comme positif. c. le même test peut être effectué en demandant au patient de sortir son ordinateur portable de son sac.	<i>Bientôt disponible</i>	<i>Bientôt disponible</i>
--	--	----------------------------------	----------------------------------

Cozen test (épicondylite latérale) a. douleur d'apparition progressive sur le versant latéral du coude. Typiquement retrouvée chez les travailleurs manuel et activités répétitive de dactylographie. b. douleur à l'épicondyle latéral déclenché par le test c. mise en place de physiothérapie, repos, antalgie et éventuellement immobilisation par une attelle.	a. le patient est assis, coude en extension et en pronation maximale. Le poignet en déviation radial, <u>poing fermé</u>. b. l'examineur est à côté du patient, d'une main il stabilise le coude et palpe l'épicondyle latéral. De l'autre main, il contre l'extension du poignet du patient. c. le fait d'avoir le patient avec le poing fermé permet de diminuer la contraction de l'extenseur digitorum communis (EDC) et le fait d'effectuer la résistance sur le versant dorso-radial du poignet de diminuer l'effet de l'extenseur ulnaire du carpe (ECU) et ainsi améliorer la spécificité du test.	 Légende : <i>flèche rouge : mouvement de l'examineur</i> <i>flèche verte : mouvement du patient</i>
---	--	--

<u>Maudsley's test (épicondylite latérale)</u> a. douleur d'apparition progressive sur le versant latéral du coude. Typiquement retrouvée chez les travailleurs manuel et activités répétitive de dactylographie. b. douleur à l'épicondyle latéral déclenché par le test c. mise en place de physiothérapie, repos, antalgie et éventuellement immobilisation par une attelle. Référence : Orthopaedic Research Institute-Tennis Elbow Testing System: A modified chair pick-up test-interrater and intrarater reliability testing and validity for monitoring lateral epicondylitis. J Shoulder Elbow Surg. 2004 Jan-Feb;13(1):72-7.	a. le patient est assis, coude en extension et en pronation maximale. Le poignet neutre et doigts en extension b. l'examineur est à côté du patient, d'une main il stabilise le coude et palpe l'épicondyle latéral. De l'autre main, il contre l'extension du majeur. c. le test serait plus à même de déterminer l'implication de l'extenseur digitorum communis (EDC) à l'inverse eu test de Cozen plus spécifique pour le court extenseur radial du carpe (ECRB).	 Légende : <i>flèche rouge : mouvement de l'examineur</i> <i>flèche verte : mouvement du patient</i>
---	---	--

<u>Reverse Cozen test (épicondylite médiale)</u> a. douleur d'apparition progressive sur le versant médial du coude. Typiquement retrouvée chez les les sportifs (golf et sport de lancer). La palpation de l'épicondyle médiale est sensible. b. douleur à l'épicondyle médial déclenché par le test c. mise en place de physiothérapie, repos, antalgie et éventuellement immobilisation par une attelle. Référence : Copas, D., Talbot, J. C. Clinical assessment of the elbow. J Orthop Trauma., 2016; 30(4): 291-300.	a. le patient est assis, coude fléchi. Avant-bras en supination, poing fermé. b. l'examineur se place à côté du patient d'une main il stabilise le coude et palpe l'épicondyle médial. De l'autre main, il contre la flexion active du poignet et du coude par le patient en tentant d'étendre le coude. c. l'épicondylite médiale étant dix fois moins fréquente que l'épicondyle latéral, il faut être attentif au diagnostics différentiel, incluant entre autre une neuropathie du nerf ulnaire.	 Légende : <i>flèche rouge : mouvement de l'examineur</i> <i>flèche verte : mouvement du patient</i> <i>cercle bleu : palpation de l'épicondyle médial</i>
---	--	--